

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061465-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARINEIDE TOME DO NASCIMENTO DE JESUS

RECORRIDO: REGINA FRANCISCA RIBEIRO DE JESUS

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CASSAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, EM RAZÃO DE NEOPLASIA MALIGNA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA. PROGNÓSTICO GRAVE E COM RISCO DE ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA CASSAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5061465-13.2024.4.02.5101

510014256530 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061465-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARINEIDE TOME DO NASCIMENTO DE JESUS

RECORRIDO: REGINA FRANCISCA RIBEIRO DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela União Federal a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada, na forma da decisão recorrida, que determinou que os réus providenciem o início do tratamento oncológico da autora, por meio de consultas, conduta cirúrgica, quimioterápica ou radioterápica, conforme o quadro clínico da paciente determinar, **no prazo de 5 dias.**

Assim fora proferida a decisão recorrida:

*"Trata-se de ação proposta por **REGINA FRANCISCA RIBEIRO DE JESUS** em face da **UNIÃO, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, com pedido de tutela de urgência, objetivando a realização de consulta oncológica para início de seu tratamento. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.*

Para tanto, afirmou que foi diagnosticada com adenocarcinoma, em 22/04/2024, sendo o prognóstico grave e com risco de óbito. Porém, apesar de encontrar-se na fila do SER desde 27/05/2024, para Consulta/ Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), até o presente momento não conseguiu iniciar o tratamento.

Inicial acompanhada de procuração e outros documentos acostados ao Evento 01.

A autora requereu a gratuidade de justiça.

Certidão no Evento 3, com informações obtidas por meio de aplicativo de mensagens, em grupo de trabalho criado a partir do convênio da Justiça Federal com a Central Estadual de Regulação.

É o breve relatório. Decido.

*Inicialmente, diante dos documentos acostados aos autos (Evento 1, Anexo2, fls. 7 e 8), **defiro a gratuidade de justiça.***

Para o deferimento da tutela jurisdicional liminar, impõe-se a demonstração, de plano, de alta probabilidade quanto ao direito pretendido e, ainda, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), ou do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, por parte do réu (art. 311, I, do CPC).

A questão em apreço deve ser analisada à luz do disposto no art. 196 da Carta Magna, que outorga verdadeiro direito subjetivo aos que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizá-lo (RE-271286/RS, Relator Min. Celso de Mello, DJ 23/08/2000).

Da mesma forma, o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990.

Trata-se, portanto, de direito fundamental, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e indissociável do direito à vida. Admite-se, pois, que o titular de tal direito possa postular, por meio da via judicial, prestação positiva do Estado que imprima ao comando constitucional eficácia plena.

Por outro lado, não se pode olvidar de que o próprio art. 196 em comento estabelece a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nesse diapasão, impende observar a “reserva do possível”, sob pena de ocasionar indesejáveis situações anti-isonômicas.

Com efeito, “o direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões singulares ou atípicas, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, podem comprometer a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes” (TRF2, Sexta Turma Especializada, AG - Agravo de Instrumento - 233160, Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, DJe 06/02/2014).

Vale dizer que, não obstante a urgência de cada caso concreto, não se pode perder de vista a possibilidade de haver outras urgências ainda maiores aguardando o mesmo tipo de tratamento. Sob esse prisma, a eventual imposição do fornecimento aleatório e indiscriminado de certo tratamento tem o potencial de inviabilizar o próprio sistema de saúde pública.

Por isso, cumpre analisar as peculiaridades de cada caso concreto, partindo-se da premissa de que, via de regra, os médicos do SUS dão atendimento às patologias verificadas. De conseguinte, a intervenção judicial deve-se limitar a hipóteses de negativa injustificada, sob pena de o Estado ver rompida com toda a sua política de saúde.

De seu turno, a Lei nº 12.732/12 - que dispõe acerca do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) - estabelece que “o paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei” (art. 1º).

Prevê, ainda, que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único” (art. 2º), e considera que “para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso” (art. 2º, §1º).

A mesma norma ainda prevê, em seu artigo 2º, §3º, que “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia.

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.

Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente.

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º.

Correlatamente, o art. 2º, §2º, Lei nº 12.732/12, estabelece que "os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos" e, por fim, o art. 5º da Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde dispõe que "cabe aos serviços de saúde dos diferentes níveis de atenção observar o fluxo disposto no art. 4º e prestar assistência adequada e oportuna aos usuários com diagnóstico comprovado de neoplasia maligna de acordo com as responsabilidades descritas na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer".

No caso concreto, a autora informa que foi diagnosticada com câncer do ceco após a realização de exame de colonoscopia, realizado em 22/04/2024 e até o presente momento não conseguiu iniciar o seu tratamento, estando na fila do SER desde 27/05/2024.

Tais informações foram todas trazidas aos autos pela autora, cuja biópsia comprovou o diagnóstico de adenocarcinoma (Evento 1, Anexo2, fl. 10), incidindo, na hipótese, o prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012 para início do tratamento oncológico.

*Portanto, ultrapassado o prazo que a Administração Pública dispõe para oferecer à autora o tratamento adequado ao seu quadro clínico, ficam evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, por razão dos riscos à saúde da autora que a demora do processamento pode provocar, além da probabilidade quanto ao direito, atribuída ao princípio de prova acerca da situação médica da parte autora, sobretudo porque, de acordo a Lei 12.732/12, os pacientes acometidos de neoplasia maligna **terão tratamento privilegiado.***

*Isto posto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA**, para que os réus providenciem o início do tratamento oncológico da autora, por meio de consultas, conduta cirúrgica, quimioterápica ou radioterápica, conforme o quadro clínico da paciente determinar, no prazo de 5 dias.*

Intimem-se para cumprimento e comprovação das medidas adotadas.

*Sem prejuízo, **citem-se os réus** para contestar a ação, na forma e prazo do CPC/15, ressaltando que, caso haja manifestação expressa das partes sobre a possibilidade de conciliação, esta será designada pelo juízo.*

Expeça-se mandado de intimação ao Sistema de Regulação do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Itapagipe, 225, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - 2026005, para cumprimento no prazo de 5 dias."

Em suas razões recursais, a União alega ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Sustenta que não cabe ao Judiciário escolher quem será tratado em primeiro lugar. Requer o efeito suspensivo e o inteiro provimento do recurso para a cassação da antecipação dos efeitos da tutela, ou, em caso de manutenção da decisão, o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Estado.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, “sic”:

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.” (grifo nosso)”

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(...)

Nos casos específicos de doenças oncológicas, a Lei 13.896/2019 promoveu alteração na Lei 12.732/2012, dispondo que exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna devem ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias, o que só reforça o reconhecimento da necessidade de rápido diagnóstico para imediato tratamento, dentro do prazo de 60 dias previsto no art. 2º da Lei 12.732/2012, *in verbis*:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019) (Vigência)

No caso em tela, a recorrida a foi submetida aos exames de colonoscopia, em 19/04/2024, que evidenciou o tumor no ceco, e histopatológico, disponibilizado em 22/04/2024, o qual confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma. É hipertensa e apresenta quadro de dor abdominal difusa e mudanças no hábito intestinal, com presença de sangue oculto nas fezes. O caso é grave e com risco de evoluir para óbito, conforme documento médico juntado à inicial dos autos originários (Evento 1 - ANEXO2):

Nome: REGINA FRANCISCA RIBEIRO DE JESUS
Data de Nascimento: 22/02/1945
ID Paciente: 19284099
Médico Requisitante: Felipe Furtado

Data Exame: 22/04/2024
Idade: 79
OS:
Número: H038439/24

HISTOPATOLÓGICO

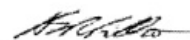
Material: Biópsia de lesão de tumor em ceco.

MACROSCOPIA:

Sete fragmentos teciduais irregulares pardos e elásticos medindo em conjunto 0,6 x 0,4 x 0,2 cm.

CONCLUSÃO MICROSCÓPICA:

- Adenocarcinoma.



Ariovaldo Rocha Filho
CRM-RJ 52754218

Avenida Churchill 14016, Centro - Rio de Janeiro - RJ, Cep 20.020-050 Tel: 21-5923-9334 e 2923-5162 / e-mail: di@defdiagport.com.br / site: <http://www.lbbdc.com/>
Nota 1: Devido à subjetividade interpretativa inerente à análise, salientamos que qualquer discordância ou dúvida do médico assistente deverá ser imediatamente comunicada, preservando-se todas as etapas, até que o caso tenha sido resolvido. A conclusão deste exame não deve ser interpretada como diagnóstico definitivo de doença, devendo sempre ser analisada em conjunto com os dados clínicos do paciente.
Nota 2: De acordo com o Código sanitário vigente, o material referente a este laudo (fotocópia e lâminas) será arquivado pelo período de 5 anos a partir desta data. Caso haja interesse em mantê-lo por mais tempo, solicitamos que sejam retidos pelo paciente ou responsável antes de descartá-lo.

Data Exame: 19/04/2024
Idade: 79
OS: 358934-78

Medicação: aos cuidados do anestesista.

Introdução do aparelho sob visão direta desde a margem anal até o ceco, que foi identificado pela presença de orifício apendicular, da confluência das ténias e da válvula ileo cecal, que tem aspecto normal. O ceco distende-se bem e apresenta lesão vegetante de superfície irregular, ocupando cerca de > 50% da circunferência e 30% da luz. Realizado múltiplas biópsias.

Os cólons foram examinados, têm calibre normal, distendem-se bem e apresentam mucosa com brilho, cor e vascularização normais. O preparo está razoável, podendo "esconder" pólipos e ou alterações menores de mucosa.

O reto apresenta-se amplo, distendendo-se bem e com mucosa normal.

1. Tumor de ceco - biópsias (Indicação de ressecção cirúrgica, avaliar condições clínicas).

Laudado por:
Dr FELIPE AVILA FURTADO
52933376

Este laudo foi assinado eletronicamente.

Atenção:
O valor preditivo de qualquer exame depende de análise conjunta do seu resultado e dados clínico-epidemiológicos do(a) paciente

Página 1 de 1

Nome REGINA FRANCISCA RIBEIRO DE JESUS	
CPF 76977781734	Data de Nascimento 22/02/1945
Unidade de Saúde 6869009 - SMS CF ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA AP 33	

Nome: REGINA FRANÇISCA RIBEIRO DE JESUS
Identificação: 000000000
Número SUS: 700005351693105

Ateste que a paciente supracitada Regina, 79 anos, hipertensa, com quadro de dor abdominal difusa e mudanças no hábito intestinal. Apresentou sangue oculto das fezes positivo. Colonoscopia evidenciou tumor em ceco e resultado de biópsia do tumor foi adenocarcinoma. Tomografias de abdome e torax sem evidência de metástases secundárias.

Caso grave com risco de evoluir para óbito já inserido no
SER 5564646, aguardando vaga desde 27/05/24
CID: C180 - Neoplasia maligna do ceco

Matheus Noves Feitosa
Médico
CRM 52.109.698-2

RIO DE JANEIRO, 26 de Julho de 2024

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr(a) **Matheus Novais Feitosa**
Médico de estratégia de saúde da família

CREMERJ CRM/RJ 1006982

SMS CF ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA AP 33. 6866009. AVENIDA VICENTE DE



CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

Parecer Técnico CRLS Nº 106386/2024

Rio de Janeiro, 30 de July de 2024

Prezados(a),

O presente parecer visa informar a Defensoria o encaminhamento realizado acerca do(s) produto(s) pleiteado(s) pelo assistido REGINA FRANCISCA RIBEIRO DE JESUS, os quais foi /foram analisado (s) pela(s) equipe(s) técnica(s) da SES e/ou SMS, resultando no seguinte encaminhamento/ parecer técnico:

PRODUTO	ENCAMINHAMENTO
CONSULTA EM ONCOLOGIA (Cod.:9837)	Defensoria

Cabe esclarecer que:

1 - O(s) produto(s) com encaminhamento para a Defensoria não se encontra(m) padronizado(s) em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Parecer Técnico Defensoria:



CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

PRODUTO	PARECER
CONSULTA EM ONCOLOGIA (Cod.:9837)	Prezados, O presente parecer visa informar à Defensoria Pública acerca do encaminhamento do produto pleiteado pela assistida REGINA FRANCISCA RIBEIRO DE JESUS, o qual foi analisado pela equipe técnica da CRLS, resultando no seguinte encaminhamento/parecer técnico: PRODUTO: CONSULTA EM ONCOLOGIA DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS. Para elaboração do presente parecer técnico foi considerado laudo médico emitido pela SMS CF ANA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CORREIA em 26/07/2024, além de tela do SER consultada na presente data. DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS Trata-se de assistido apresentando adenocarcinoma de ceco. Pleiteando consulta em oncologia. DISPONIBILIDADE NO SUS Informa-se que as vagas disponíveis para a referida demanda são reguladas pelo Sistema Estadual de Regulação (SER). Acréscita-se que em consulta ao sistema citado, a assistida encontra-se em fila desde 27/05/2024 para Ambulatório 1ª Vez ? Coloproctologia (Oncologia). Cumprir informar que não há vagas no presente momento para a referida demanda. Deste modo, diante da impossibilidade de resolução administrativa, encaminha-se à Defensoria. ANA BEATRIZ MARONES DE GUSMÃO MACHADO COURI MÉDICA/SES/SJ/CRLS CRM 5281640-0

Apesar do diagnóstico, até o presente momento não conseguiu iniciar o seu tratamento, estando na fila do SER desde 27/05/2024.

Superada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada deferida pelo Juízo *a quo*.

O deferimento do efeito suspensivo tem por objetivo impedir a ocorrência de dano de difícil reparação até o pronunciamento definitivo do colegiado.

Nesse contexto, analisando o presente caso não vislumbro qualquer possibilidade de dano irreparável à recorrente, cujas razões recursais apenas atacam o provimento antecipatório sem demonstrar fatos hábeis que pudessem afastar a verossimilhança da pretensão autoral.

Constato, ao reverso, que o risco de dano irreparável corre em prejuízo da Recorrida, diagnosticada com Neoplasia Maligna do Ceco, necessitando de consulta oncológica, em caráter de urgência, sob risco de evolução do seu quadro clínico, não tendo o recorrente juntado prova

h  bil e suficiente a ilidir as conclus  es do Ju  zo *a quo*.

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipac  o de tutela previstos no artigo 300 do CPC e entendo que os argumentos da Uni  o n  o s  o suficientes a gerar a revis  o de plano da referida decis  o.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a decis  o do evento 3. Sem custas, nem honor  rios nos termos do art. 55 da lei n   9.099/95, por se tratar de recurso contra decis  o interlocut  ria. Intimem-se e, ap  s o tr  nsito em julgado, devolvam-se os autos ao ju  zo de origem.   como voto.